



RUMAH SAKIT
PRIMA HUSADA

**PEDOMAN ETIK DAN DISIPLIN
RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA**

Jl. Raya Surabaya - Malang No. KM 54, Sukorejo - Pasuruan

Telp. 0343 - 6745000

Email : sekretariat@sukorejo.rs-primahusada.com

www.rs-primahusada.com

Peraturan Direktur Rumah Sakit Prima Husada

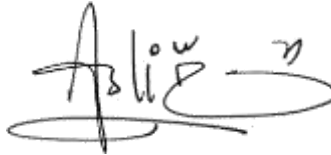
Tentang
Pedoman Etik dan Disiplin

Disusun oleh :
Penanggung Jawab Etik dan Disiplin



dr. I Gede Made Oka Rahaditya, Sp.OT

Disetujui oleh :
Authorized Person



Dr. dr. Aslichah, M. Kes. AFP

Ditetapkan oleh :

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns. Heni Indra Wulansari, S.Kep.M.Kep

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmatnya Pedoman Etik dan Disiplin dapat diselesaikan dengan tepat waktu sesuai dengan kebutuhan RS. Prima Husada.

Rumah sakit merupakan institusi pelayanan kesehatan yang kompleks, tempat bertemunya berbagai profesi, teknologi, dan latar belakang masyarakat. Dalam dinamika operasionalnya, benturan kepentingan dan dilema moral sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, pedoman ini disusun sebagai acuan baku dan kompas moral bagi seluruh jajaran manajemen, komite, staf klinis, hingga staf non-klinis dalam bersikap, bertindak, dan mengambil keputusan.

Pedoman Etik ini mengintegrasikan prinsip-prinsip tata kelola korporat yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*). Kami berharap, kehadiran dokumen ini tidak sekadar menjadi pemenuhan standar akreditasi, melainkan dihayati dan diterapkan secara nyata dalam aktivitas pelayanan sehari-hari demi menjamin keselamatan pasien (*patient safety*) dan perlindungan hukum bagi seluruh staf.

Kami mengucapkan terima kasih kepada Tim Penyusun yang telah berjuang untuk menyelesaikan standar ini dengan baik. Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada para kontributor yang telah memberikan masukan sangat berharga.

Semoga dengan dipergunakan Pedoman Etik dan Disiplin ini, mutu pelayanan dan keselamatan pasien rumah sakit Prima Husada dapat lebih baik.

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns.Heni Indra Wulansari, S.Kep.M.Kep



TIM PENYUSUN

PEDOMAN ETIK DAN DISIPLIN

1. Ns.Heni Indra Wulansari, S.Kep.M.Kep
2. Mariatul Rochmawati Nuris Wahyuni, S.Kep.,Ns
3. dr. Rudi Priyo Utomo, Sp.OG
4. dr. Dimas Aryo Pamungkas, Sp.PD
5. dr. Robby, Sp.An-Ti
6. Nur Lailatul Farida, S.Kep,Ns
7. Novia Ainur Pratiwi, S.KM
8. Laili Choirul Umma, S.Farm, Apt
9. Rizki Dwi Ramadhani, Amd.Kep

DAFTAR ISI

JUDUL	
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
TIM PENYUSUN	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA	vii
LAMPIRAN.....	1
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Manfaat.....	2
BAB II.....	3
TATA KELOLA DAN KEPEMIMPINAN	3
2.1 Penetapan Ketua, Tugas dan Tanggung Jawab.....	3
2.2 Penetapan Sekretaris, Tugas dan Tanggung Jawab	3
2.3 Tersedianya Anggaran Yang Cukup	4
2.4 Sistem Pelaporan Dari Sekretaris Ke Ketua Komite	4
BAB III.....	5
PROGRAM KERJA ETIK DAN DISIPLIN	5
3.1 Program Edukasi dan Pencegahan.....	5
3.2 Program Penanganan Pelanggaran dan Dilema Etik.....	5
3.3 Program Pemulihan dan Monitoring	5
BAB IV	6
TATA LAKSANA DAN ALUR PENANGANAN KASUS ETIK DAN DISIPLIN	6
4.1 Prinsip Penangan Kasus	6
4.2 Alur Operasional Penanganan Kasus.....	6
4.3 Tata Laksana	6
BAB V	6
KLASIFIKASI PELANGGARAN DAN SANKSI	Error! Bookmark not defined.
5.1 Klasifikasi Pelanggaran	Error! Bookmark not defined.
5.2 Jenis Sanksi dan Rekomendasi Pembinaan.....	10
5.3 Mekanisme Pertimbangan Sanksi	10
BAB VI	11
MONITORING DAN EVALUASI	Error! Bookmark not defined.
6.1 Monitoring dan Pengawasan Aktivitas.....	11
6.2 Evaluasi Program Kerja.....	11
6.3 Peninjauan Ulang Regulasi	11
BAB VII	12
PELAPORAN	12
BAB VIII	13
PENUTUP	13



DAFTAR TABEL

Tabel 5.2 Jenis sanksi dan Rekomendasi Pembinaan



PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA

NOMOR :

TENTANG

PEDOMAN ETIK DAN DISIPLIN

DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA,

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka upaya menangani pelanggaran etik yang terjadi di rumah sakit serta pembinaan dan penegakan kedisiplinan, maka diperlukan pelaksanaan tugas Tim Etik RS Prima Husada;

b. Bahwa agar Tim Etik RS Prima Husada dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka perlu adanya Pedoman Pengorganisasian Tim Etik RS Prima Husada sebagai landasan penyelenggaraan pelayanan Tim Etik RS Prima Husada yang ditetapkan dalam keputusan Direktur RS Prima Husada;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Pedoman Etik dan Disiplin;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;

3. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Keselamatan Pasien;

4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2022 Tentang Komite Etik dan Hukum Rumah Sakit;

5. Permenkes Nomor 3 Tahun 2025 tentang Penegakan Disiplin Profesi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan;

6. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1596/2024 tentang Standar Akreditasi Rumah Sakit;

7. Keputusan Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Nomor HK.02.02/D/47104/2024 tentang Instrumen Survei Akreditasi Rumah Sakit;

8. Keputusan Direktur Perseroan Terbatas Disa Prima Medika Nomor: 1110/DPM/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo;

9. Keputusan Direktur Rumah Sakit Prima Husada Nomor: 935.4/RSPHS/I-KEP/DIR/XI/2025 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Prima Husada;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DIREKTUR RUMAH SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG PEDOMAN ETIK DAN DISIPLIN.**

Pasal 1

Rumah sakit menetapkan tata kelola untuk manajemen etis etika pegawai agar menjamin bahwa asuhan pasien diberikan didalam norma-norma bisnis, finansial, etis, dan hukum yang melindungi pasien dan hak mereka.



Pasal 2

- (1) Rumah sakit dalam menjalankan operasionalnya bertanggung jawab terhadap lingkungan agar tidak terjadi pencemaran yang merugikan masyarakat.
- (2) Direktur Rumah sakit menetapkan regulasi tentang tata kelola etik rumah sakit yang mengacu pada kode etik rumah sakit nasional, membentuk komite etik yang mengelola rumah etika Rumah sakit dan mengkoordinasikan sub komite etik profesi dan menetapkan kode etik pegawai rumah sakit.
- (3) Direktur Rumah sakit membuat keputusan terkait pengadaan dan penggunaan sumber daya dengan mempertimbangkan mutu dan keselamatan.
- (4) Direktur Rumah sakit memastikan praktek non diskriminatif dalam hubungan kerja dan ketentuan atas asuhan pasien dengan mengingat norma hukum dan budaya.
- (5) Direktur Rumah sakit memastikan kepatuhan staff terhadap etika pegawai rumah sakit.

pasal 3

- (1) Menyusun kebijakan yang kondusif bagi pelayan kesehatan yang sesuai dengan kode etik Rumah sakit; dan melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan serta pemberian sanksi bagi pelanggaran etik rumah sakit.
- (2) Rumah sakit harus jujur dan terbuka, peka terhadap saran dan kritik, serta berusaha menanggapi keluhan pasien dan masyarakat.
- (3) Rumah sakit berkewajiban menetapkan kerangka kerja untuk manajemen yang menjamin asuhan pasien yang baik diberikan sesuai norma etik, moral, bisnis, dan hukum yang berlaku.

Pasal 4

- (1) Rumah sakit mengungkapkan pemilikannya serta mencegah konflik kepentingan bila melakukan rujukan.
- (2) Rumah sakit secara jujur menjelaskna pelayanan yang disediakan kepada pasien.
- (3) Rumah sakit dalam melakukan promosi pemasaran harus bersifat informatif, tidak komporatif pada dasar yang nyata.
- (4) Rumah sakit membuat tagihan yang akurat untuk layanannya untuk memastikan bahwa insentif finansial dan pengaturan pembayaran tidak mempengaruhi asuhan pasien.

Pasal 5

- (1) Rumah sakit mempunyai sistem pelaporan bila terjadi dilema etis dalam asuhan pasien dan dalam pelayanan non klinis.
- (2) Regulasi tentang manajemen etis yang mendukung hal-hal yang dikonfrontasi pada dilema etis dalam asuhan pasien yang telah dilaksanakan.
- (3) Regulasi untuk manajemen etis yang mendukung hal-hal yang dikonfrontasi pada dilema etis dalam pelayanan nonklinis telah dilaksanakan.
- (4) Pelaporan bila terjadi dilema etis dalam asuhan pasien dan dalam pelayanan non klinis telah dilaksanakan.

BAB I

KEWAJIBAN UMUM RUMAH SAKIT

Pasal 6

Rumah sakit harus menaati Kode Etik Rumah Sakit (KODERSI) dan rumah sakit wajib menyusun kode etik sendiri dengan mengacu pada KODERSI dan tidak bertentangan dengan prinsip moral dan peraturan perundangan.



Pasal 7

Rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna sesuai kebutuhan klinis pasien dan kemampuan rumah sakit.

Pasal 8

Rumah sakit berkewajiban menyelenggarakan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan yang aman, mengutamakan kepentingan pasien dan keluarga, bermutu, non diskriminatif, efektif, efisien sesuai dengan standar pelayanan Rumah sakit.

Pasal 9

Rumah sakit harus mengikuti perkembangan dunia perumahan-sakitan.

Pasal 10

Rumah sakit harus dapat mengawasi serta bertanggungjawab terhadap semua kejadian di rumah sakit. Dalam penyelenggaraannya rumah sakit dilakukan audit berupa audit kinerja dan audit klinis.

Pasal 11

Rumah sakit berkewajiban menetapkan kerangka kerja untuk manajemen yang menjamin asuhan pasien yang baik diberikan sesuai norma etik, moral, bisnis dan hukum yang berlaku.

Pasal 12

Rumah sakit harus memelihara semua catatan/arsip baik medik maupun non medik secara baik. Pencatatannya, penyimpanan, dan pelaporan (termasuk insiden keselamatan pasien) tentang semua kegiatan penyelenggaraan Rumah sakit dilaksanakan dalam bentuk Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit.

Pasal 13

Rumah sakit dalam melakukan promosi pemasaran harus bersifat informatif, tidak komparatif, berpijak pada dasar yang nyata, tidak berlebihan, dan berdasarkan Kode Etik Rumah Sakit Indonesia.

BAB II

KEWAJIBAN RUMAH SAKIT TERHADAP MASYARAKAT

Pasal 14

Rumah sakit harus mengutamakan pelayanan yang baik dan bermutu secara berkesinambungan serta tidak mendahulukan urusan biaya; rumah sakit harus melaksanakan fungsi sosial dengan menyediakan fasilitas pelayanan kepada pasien tidak mampu/ miskin, pasien gawat darurat, dan korban bencana.

Pasal 15

Rumah sakit berkewajiban memberikan pelayanan yang menghargai martabat dan kehormatan pasien; karyawan rumah sakit menunjukkan sikap dan perilaku yang sopan dan santun, sesuai dengan norma sopan santun dan adat istiadat yang berlaku setempat.

Pasal 16

Rumah sakit harus senantiasa menyesuaikan kebijakan pelayanannya pada harapan dan kebutuhan masyarakat setempat.



Pasal 17

Rumah sakit harus memberikan informasi yang benar tentang pelayanan Rumah sakit kepada masyarakat.

Pasal 18

Rumah sakit harus jujur dan terbuka, peka terhadap saran dan kritik, serta berusaha menanggapi keluhan pasien dan masyarakat.

Pasal 19

Rumah sakit dalam menjalankan operasionalnya bertanggungjawab terhadap lingkungan agar tidak terjadi pencemaran yang merugikan masyarakat.

BAB III

KEWAJIBAN RUMAH SAKIT TERHADAP PASIEN

Pasal 20

Rumah sakit berkewajiban menghormati dan mengindahkan hak pasien dan keluarganya selama dalam pelayanan.

Pasal 21

Rumah sakit wajib menerapkan standar keselamatan pasien.

Pasal 22

Rumah sakit harus memberikan penjelasan kepada pasien dan atau keluarganya tentang apa yang di derita pasien, tindakan apa yang dilakukan, dan siapa yang melakukannya.

Pasal 23

Rumah sakit harus meminta persetujuan atau penolakan pasien sebelum melakukan tindakan medik. Persetujuan pasien diberikan setelah pasien mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin terjadi, dan prognosis terhadap tindakan yang dilakukan serta perkiraan biaya pengobatan.

Pasal 24

Rumah sakit mendukung hak pasien dan keluarga untuk berpartisipasi dalam proses pelayanan.

Pasal 25

Rumah sakit harus menjelaskan kepada pasien dan keluarganya tentang hak, kewajiban, dan tanggungjawab mereka yang berhubungan dengan penolakan atau tidak melanjutkan pengobatan, serta akibat lanjut dari penolakan ini. Rumah sakit berkewajiban membantu dengan memberikan alternatif bagi pasien dan keluarganya.

Pasal 26

Rumah Sakit berkewajiban merujuk dan memberikan penjelasan kepada pasien yang memerlukan pelayanan di luar kemampuan pelayanan rumah sakit.

Pasal 27

Rumah Sakit harus mengupayakan pasien mendapatkan kebutuhan privasi dan berkewajiban menyimpan rahasia kedokteran. Rahasia kedokteran hanya dapat dibuka untuk



kepentingan kesehatan pasien, untuk pemenuhan permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum, atas persetujuan pasien sendiri, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Rumah sakit berkewajiban memperhatikan kebutuhan khusus pasien dan mengurangi kendala fisik, bahasa dan budaya, serta penghalang lainnya dalam memberikan pelayanan.

Pasal 29

Rumah Sakit berkewajiban melindungi pasien yang termasuk kelompok rentan seperti anak-anak, individu yang memiliki kemampuan berbeda (difabel), lanjut usia, dan lainnya.

Pasal 30

Rumah sakit berkewajiban menggunakan teknologi kedokteran dengan penuh tanggung jawab.

BAB IV

KEWAJIBAN RUMAH SAKIT TERHADAP PIMPINAN,
STAF DAN KARYAWAN

Pasal 31

Rumah sakit harus menjamin agar pimpinan, staf, dan karyawannya memperoleh jaminan sosial nasional.

Pasal 32

Setiap Rumah Sakit harus menyelenggarakan tata kelola rumah sakit, tata kelola klinis, dan tata kelola pasien yang baik.

Pasal 33

Rumah sakit harus menetapkan ketentuan pendidikan, keterampilan, pengetahuan, dan persyaratan lain bagi seluruh tenaga kesehatan.

Pasal 34

Rumah sakit harus menjamin agar koordinasi serta hubungan yang baik antara seluruh tenaga di rumah sakit dapat terpelihara.

Pasal 35

Rumah sakit berkewajiban menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Manusia serta memberi kesempatan kepada seluruh tenaga rumah sakit untuk meningkatkan diri, menambah ilmu pengetahuan, dan keterampilannya.

Pasal 36

Rumah sakit harus mengawasi agar penyelenggaraan pelayanan dilakukan berdasarkan standar profesi yang berlaku. Setiap tenaga kesehatan yang bekerja di rumah sakit harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan rumah sakit, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi, menghormati hak pasien, dan mengutamakan keselamatan pasien.



Pasal 37

Rumah sakit berkewajiban memberi kesejahteraan kepada karyawan dan menjaga keselamatan kerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.

BAB V

HUBUNGAN RUMAH SAKIT DENGAN LEMBAGA TERKAIT

Pasal 33

Rumah sakit harus memelihara hubungan baik antar rumah sakit dan menghindarkan persaingan yang tidak sehat.

Pasal 34

Rumah sakit harus menggalang kerjasama yang baik dengan instansi atau badan lain yang bergerak di bidang kesehatan dan kemanusiaan.

Pasal 35

Rumah sakit harus berusaha membantu kegiatan pendidikan tenaga kesehatan dan penelitian dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang terkait dengan kedokteran dan kesehatan.

Pasal 36

Rumah sakit berkewajiban menyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan kepentingan lokal dan nasional.

Ditetapkan di Sukorejo
Pada tanggal 09 November 2025
Direktur Rumah Sakit Prima Husada,



Ns.Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR RUMAH
SAKIT PRIMA HUSADA
TENTANG
PEDOMAN ETIK DAN DISIPLIN,

PEDOMAN ETIK DAN DISIPLIN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rumah Sakit sebagai salah satu sarana kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Oleh karena itu rumah sakit dituntut untuk dapat memberikan pelayanan yang bermutu sesuai dengan standar yang sudah ditentukan.

Rumah sakit merupakan suatu institusi yang melibatkan banyak profesi di dalamnya. Tujuan utama dari rumah sakit adalah memberikan pelayanan yang bermutu tinggi kepada para pelanggannya. Pelayanan tersebut dapat terwujud melalui interaksi berbagai profesi yang bekerja pada rumah sakit, ditunjang dengan berbagai peralatan, baik peralatan medik maupun non medik, yang sederhana sampai peralatan canggih.

Adanya interaksi antar manusia yang terjadi dalam lingkup pelayanan rumah sakit, maupun interaksi dengan para pelanggan, memerlukan suatu pengaturan agar interaksi yang terjadi dapat selaras dan tidak ada pihak yang dirugikan. Salah satu bentuk pengaturan yang diperlukan adalah ditetapkannya etika bagi seluruh sumber daya manusia rumah sakit, sehingga akan menumbuhkan rasa saling percaya dengan landasan saling menghargai.

Etika Pegawai Rumah Sakit diperlukan sebagai pengaturan interaksi yang terjadi dalam pelayanan profesi dalam melaksanakan tugas masing-masing, di samping Etika Profesi sebagai pedoman tenaga kesehatan dalam melaksanakan profesinya. Etika Pegawai Rumah Sakit merumuskan norma moral dasar bagi seluruh sumber daya manusia rumah sakit, yang mengacu dari etika umum yang berlaku universal. Dengan demikian Etika Pegawai Rumah Sakit merupakan kaidah khusus sebagai pedoman setiap sumber daya manusia rumah sakit dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari di rumah sakit.

Berlandaskan pada kesadaran itu, RS Prima Husada menetapkan Etika Pegawai Rumah Sakit Prima Husada yang memuat rangkuman nilai-nilai dan norma yang dijadikan pegangan oleh setiap pegawai RS Prima Husada dalam melaksanakan tugas profesinya dan saat berinteraksi dengan pelanggan, baik pelanggan eksternal, internal maupun perantara.

Pedoman etik ini dapat membantu tenaga kesehatan, staf, serta pasien dan keluarga pasien ketika menghadapi dilema etis dalam asuhan pasien, seperti perselisihan antar profesional dan perselisihan antara pasien dan dokter mengenai keputusan dalam asuhan dan pelayanan. Sesuai regulasi, Rumah Sakit dapat menetapkan

Komite/Panitia/Tim yang mengelola etik RS, termasuk melakukan koordinasi antara komite etik RS dengan subkomite etik profesi medis dan sub komite etik keperawatan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka Rumah Sakit Prima Husada menyusun Pedoman Etik dan Disiplin di Rumah Sakit merupakan salah satu faktor pendukung yang sangat penting untuk mendapat dukungan dan komitmen dari pimpinan rumah sakit dan seluruh petugas.

1.2 Tujuan

Tujuan Umum :

Mewujudkan tata kelola rumah sakit yang baik (*Good Corporate Governance*) dan tata kelola klinis yang baik (*Good Clinical Governance*).

Tujuan Khusus :

1. Menyediakan acuan baku pengorganisasian Tim Etik.
2. Menjamin independensi Tim Etik dalam memberikan rekomendasi atau penyelesaian konflik etik.
3. Memperjelas koordinasi antara Tim Etik dengan jajaran manajemen serta komite fungsional lainnya (Komite Medik, Komite Keperawatan, dsb).

1.3 Manfaat

1. Tercapainya patient safety.
2. Perlakuan Adil dan Tanpa Diskriminasi (*Justice*).
3. Menciptakan Lingkungan Kerja yang Sehat (*Harmonious Collaboration*).

BAB II

TATA KELOLA DAN KEPEMIMPINAN

2.1 Penetapan Ketua, Tugas, Tanggung jawab, dan Wewenang.

Uraian tugas:

1. Menyusun Program Kerja Tahunan.
2. Merencanakan program pembinaan etika, sosialisasi Code of Conduct, serta jadwal audit kepatuhan etik dan disiplin di rumah sakit.
3. Memimpin dan Mengendalikan Tim : Mengoordinasikan sub-tim (Sub-Tim Edukasi dan Sub-Tim Penanganan Kasus) agar program kerja berjalan sesuai target waktu.
4. Merumuskan Rekomendasi Sanksi/Penyelesaian : Menyusun dokumen telaah kritis, kesimpulan sidang, dan rekomendasi sanksi secara tertulis untuk diserahkan kepada Direktur Utama.
5. Melakukan Mediasi Sengketa : Menjadi mediator utama dalam menyelesaikan konflik atau kesalah pahaman terkait etik/ komunikasi, baik antar-staf profesi maupun antara pihak RS dengan pasien/ keluarga.
6. Memberikan Laporan Berkala : Menyusun dan menyampaikan laporan kinerja berkala (triwulanan dan tahunan) mengenai peta kepatuhan perilaku pegawai kepada Direktur Utama.

Tanggung jawab:

1. Bertanggung jawab terhadap evaluasi, rekomendasi dan tindaklanjut program dengan melaksanakan pertemuan dan pelaporan berkala setiap 3 bulan.
2. Bertanggung jawab terhadap penyusunan dan evaluasi pelaksanaan kerja tim etik

Wewenang:

1. Memanggil dan meminta keterangan dari staf klinis, staf non-klinis, kepala unit, bahkan jajaran manajemen yang diduga terlibat atau mengetahui suatu pelanggaran etik/disiplin.
2. Mengakses, memeriksa, dan menyalin dokumen internal rumah sakit yang diperlukan untuk investigasi (seperti berkas rekam medis, rekaman CCTV, log absensi, atau berkas *informed consent*) dengan tetap menjaga kerahasiaannya.
3. Membentuk dan menunjuk anggota panel sidang khusus (jika diperlukan dapat melibatkan ahli eksternal atau komite profesi lain) untuk menangani kasus yang sangat spesifik atau rumit.
4. Menghentikan proses pemeriksaan atau investigasi jika dalam telaah awal terbukti laporan yang masuk tidak memiliki dasar bukti yang sah, bersifat fitnah, atau bukan ranah etik dan disiplin.
5. Memberikan rekomendasi kepada manajemen untuk mengubah atau merevisi kebijakan operasional/SOP rumah sakit jika ditemukan bahwa pelanggaran disiplin terjadi akibat celah sistem (*system failure*).

2.2 Penetapan Sekretaris, Tugas, Tanggung jawab, dan Wewenang.

Uraian tugas:

1. Mengumpulkan data statistik tren pelanggaran bulanan, merekapitulasi status penyelesaian kasus, dan menyusun draf Laporan Berkala (triwulanan/tahunan) bersama Ketua Tim untuk diserahkan kepada Direktur Utama.
2. Menyusun agenda kegiatan tahunan, menjadwalkan sosialisasi/edukasi etik bagi pegawai, serta mengoordinasikan waktu pelaksanaan sidang agar kuorum terpenuhi.

-
3. Mencatat jalannya rapat etik dan disiplin.

Tanggung jawab:

1. Bersama Komite melakukan sosialisasi terkait Etik dan Disiplin di Rumah sakit.
2. Bersama Komite menjaga kerahasiaan dokumen.

Wewenang:

1. Mengumpulkan data.
2. Menerima laporan pengaduan dari awal dan berhak meminta kelengkapan bukti pendukung kepada pelapor sebelum dokumen tersebut diserahkan kepada Ketua untuk ditelaah.
3. Menolak permintaan salinan dokumen atau notulen sidang dari pihak luar mana pun (termasuk dari unit kerja lain di RS) tanpa izin tertulis dari Ketua Tim Etik dan Disiplin.
4. Mengusulkan kebutuhan anggaran operasional tahunan tim (seperti anggaran penggandaan materi, konsumsi rapat, hingga sarana penyimpanan data yang aman) kepada bagian logistik/keuangan RS.

2.3 Tersedianya Anggaran Yang Cukup

1. Pendidikan atau Pelatihan (diklat).
2. Pengadaan fasilitas pelayanan penunjang.
3. Untuk pelaksanaan program, monitoring, evaluasi, laporan, dan rapat rutin.
4. Intensif/Tunjangan/Reward untuk Komite.

2.4 Sistem Pelaporan Dari Sekretaris Ke Ketua Komite

Sekretaris melaporkan informasi yang dikelola dengan mekanisme pelaporannya dibagi menjadi dua jalur utama: Pelaporan Kasus Baru (Insidental) dan Pelaporan Kinerja (Berkala).

BAB III

PROGRAM KERJA ETIK DAN DISIPLIN

Rumah sakit memiliki program Etik dan Disiplin secara menyeluruh untuk Terwujudnya budaya berperilaku etis, disiplin, dan profesional di lingkungan rumah sakit demi keselamatan pasien dan mutu pelayanan.

Program Etik dan Disiplin antara lain :

3.1 Pilar I : Program Edukasi dan Pencegahan (Preventif)

1. Penyusunan dan Sosialisasi *Code of Conduct* (Panduan Perilaku Utama) :
 - a. Mengadakan sosialisasi berkala bagi pegawai baru (saat orientasi) dan pegawai lama minimal 1 kali setahun.
 - b. Target: 100% pegawai menandatangani Pakta Integritas kepatuhan terhadap *Code of Conduct*.
2. Edukasi Dilema Etik Klinis dan Bioetika :
 - a. Workshop tahunan penanganan kasus akhir kehidupan (*End of Life*), penolakan tindakan medis, pemberian informasi medis (*informed consent*), dan penanganan keputusan *Do Not Resuscitate* (DNR).
3. Kampanye Pencegahan Perilaku Tidak Dapat Diterima (*Disruptive Behavior*) :
 - a. Edukasi mengenai batasan pelecehan verbal, emosional, psikologis, atau fisik antar staf maupun terhadap pasien.

3.2 Pilar II: Program Penanganan Pelanggaran dan Dilema Etik (Kuratif)

1. Pengelolaan *Whistleblowing System* (Sistem Pengaduan) :
 - a. Menyediakan kotak saran fisik, nomor aduan rahasia, atau email pengaduan etik/disiplin yang terjamin kerahasiaannya.
2. Penyelenggaraan Sidang Etik dan Pembentukan Panel *Ad-Hoc* :
 - a. Melakukan klarifikasi, investigasi, dan persidangan terhadap laporan dugaan pelanggaran etik atau disiplin profesi yang masuk.
3. Penyusunan Rekomendasi Formal Tindak Lanjut :
 - a. Menyusun surat rekomendasi kepada Direktur terkait keputusan sanksi, pembatasan kewenangan klinis (*clinical privileges*), atau pembinaan staf.

3.3 Pilar III: Program Pemulihan dan Monitoring (Evaluatif)

1. Audit Etik dan Disiplin Staf :
 - a. Melakukan pengawasan lapangan berkala di unit-unit berisiko tinggi (IGD, ICU, NICU, Rawat Inap).
2. Program Rehabilitasi/Pembinaan Staf :
 - a. Melakukan pendampingan terhadap staf yang sedang menjalani sanksi perilaku agar dapat kembali bekerja sesuai standar profesi.
3. Penyusunan Laporan Kinerja Berkala :
 - a. Mengompilasi tren kasus etik/disiplin setiap semester untuk dilaporkan kepada Direktur dan Dewan Pengawas.

BAB IV

TATA LAKSANA DAN ALUR PENANGANAN KASUS ETIK DAN DISIPLIN

4.1 Prinsip Penanganan Kasus

Dalam melakukan tata laksana penanganan dugaan pelanggaran etik dan disiplin, Komite Etik dan Disiplin wajib mematuhi prinsip-prinsip berikut :

1. Praduga Tak Bersalah (*Presumption of Innocence*) : Staf yang dilaporkan dianggap tidak bersalah sampai terbukti sebaliknya melalui sidang pleno komite.
2. Kerahasiaan (*Confidentiality*) : Identitas pelapor, terlapor, saksi, serta seluruh berkas pemeriksaan bersifat rahasia dan tidak boleh diakses oleh pihak yang tidak berkepentingan.
3. Objektivitas dan Imparsialitas : Pemeriksaan dilakukan berdasarkan bukti nyata (fakta klinis/perilaku) tanpa dipengaruhi oleh unsur subjektivitas atau konflik kepentingan personal.
4. Hak Membela Diri (*Due Process*) : Terlapor diberikan kesempatan yang cukup untuk memberikan klarifikasi, kronologi tertulis, dan mengajukan bukti pembelaan diri.

4.2 Alur Operasional Penanganan Kasus

Setiap aduan atau temuan pelanggaran harus diselesaikan melalui alur sebagai berikut :

1. Penerimaan Laporan & Verifikasi (Maksimal 3x24 Jam)
Laporan tertulis masuk melalui sistem pengaduan resmi. Ketua Komite melakukan verifikasi awal untuk menentukan apakah kasus masuk ranah etik, disiplin profesi, administrasi, atau hukum pidana.
2. Investigasi & Pengumpulan Bukti (Maksimal 7 Hari Kerja)
Komite membentuk Tim Investigasi/Panel Ad-Hoc. Dilakukan pengumpulan bukti-bukti objektif (rekam medis, CCTV, logbook, audit internal) dan wawancara saksi-saksi
3. Panggilan & Klarifikasi Terlapor (Maksimal 2x Panggilan Resmi)
Staf yang dilaporkan dipanggil secara resmi untuk memberikan klarifikasi, pembelaan diri, dan kronologi tertulis dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP).
4. Sidang Panel Etik / Disiplin (Forum Pengambilan Keputusan)
Anggota komite mengadakan sidang pleno tertutup untuk menganalisis pemenuhan unsur pelanggaran berdasarkan *Code of Conduct* dan standar profesi. Keputusan diambil secara musyawarah mufakat
5. Penyusunan & Penyerahan Rekomendasi (Maksimal 2 Hari Pasca-Sidang)
Komite menyusun Surat Rekomendasi yang berisi kesimpulan kasus dan usulan sanksi/pembinaan, yang kemudian diserahkan langsung secara rahasia kepada Direktur Utama. Eksekusi sanksi sepenuhnya berada di tangan Direktur.

4.3 Tata Laksana

Langkah 1: Penerimaan Laporan dan Verifikasi Awal

1. Sumber Laporan : Laporan dapat berasal dari pasien/keluarga, sesama staf klinis (dokter/perawat/penunjang), kepala unit kerja, atau temuan dari manajemen (manajemen komplain).
2. Verifikasi : Ketua Komite memeriksa kelengkapan laporan (minimal memuat nama terlapor, waktu kejadian, kronologi singkat, dan bukti awal jika ada).
3. Disposisi Ranah:

-
- a. Jika kasus murni masalah administratif/personalia, dilimpahkan ke SDM/HRD.
 - b. Jika kasus mengandung unsur kriminal/pidana, langsung dikoordinasikan dengan Direksi dan Bagian Hukum.
 - c. Jika kasus mengandung unsur pelanggaran perilaku/etik/disiplin klinis, proses dilanjutkan.

Langkah 2: Investigasi dan Pengumpulan Bukti (*Fact Finding*)

1. Komite menunjuk minimal 3 (tiga) orang anggota untuk menjadi Tim Investigasi Kasus. Jika melibatkan keahlian spesifik (misalnya pelayanan NICU atau OK), komite dapat mengundang mitra bestari (*peer group*) eksternal yang independen.
2. Tim Investigasi berhak mengumpulkan dokumen pendukung, seperti :
 - a. Berkas Rekam Medis pasien terkait
 - b. Catatan asuhan keperawatan / logbook harian staf.
 - c. Rekaman CCTV di sekitar lokasi kejadian (jika relevan).
 - d. Hasil wawancara awal dengan saksi yang melihat langsung kejadian.

Langkah 3: Panggilan dan Klarifikasi Terlapor

1. Sekretariat komite mengirimkan Surat Panggilan Klarifikasi Resmi yang bersifat rahasia (*confidential*) kepada terlapor, minimal 2 hari sebelum tanggal pertemuan.
2. Jika terlapor mangkir sebanyak 2 (dua) kali panggilan berturut-turut tanpa alasan yang sah, komite berhak melanjutkan proses sidang tanpa kehadiran terlapor (*verstek*).
3. Selama proses klarifikasi, dibuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang wajib ditandatangani oleh Tim Investigasi dan staf terlapor sebagai bukti keabsahan informasi.

Langkah 4: Sidang Pleno Komite Etik dan Disiplin

1. Sidang dipimpin oleh Ketua Komite dan dihadiri oleh seluruh anggota komite (memenuhi kuorum minimal 2/3 anggota).
2. Agenda sidang meliputi :
 - a. Pembacaan laporan aduan dan hasil temuan tim investigasi.
 - b. Pembacaan hasil BAP dan pembelaan diri dari staf terlapor.
 - c. Diskusi panel untuk menentukan kategori pelanggaran (Ringan/Sedang/Berat) berdasarkan Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*).
3. Pengambilan keputusan diutamakan melalui musyawarah mufakat. Jika tidak tercapai, dilakukan voting suara terbanyak.

Langkah 5: Penyusunan Surat Rekomendasi kepada Direktur

1. Hasil keputusan sidang dituangkan dalam dokumen formal bernama Surat Rekomendasi Komite Etik dan Disiplin.
2. Isi Surat Rekomendasi wajib memuat :
 - a. Identitas lengkap staf terlapor.
 - b. Ketentuan *Code of Conduct* yang dilanggar.
 - c. Pertimbangan yang memberatkan dan meringankan terlapor.
 - d. Usulan sanksi konkret atau program pembinaan ulang yang disarankan.
3. Surat diserahkan secara tertutup dan langsung kepada Direktur Utama Rumah Sakit. Keputusan akhir eksekusi sanksi atau pembinaan mutlak berada di bawah wewenang Direktur Utama melalui penerbitan SK Direktur.

KLASIFIKASI PELANGGARAN DAN SANKSI

Untuk menjamin keadilan (*just culture*) dalam pembinaan pegawai, setiap bentuk penyimpangan harus diklasifikasikan berdasarkan bobot dampaknya terhadap keselamatan pasien, nama baik rumah sakit, dan lingkungan kerja.

5.1 Klasifikasi Pelanggaran

1. Pelanggaran Ringan

Pelanggaran yang bersifat administratif, kelalaian minor yang tidak berdampak langsung pada keselamatan pasien atau tidak menimbulkan kerugian finansial/reputasi bagi rumah sakit.

a. Ranah Etik (Perilaku) :

- 1) Tidak menggunakan atribut seragam lengkap atau tanda pengenal (*name tag*) selama bertugas.
- 2) Bersikap kurang ramah, tidak menerapkan 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) kepada pasien atau rekan kerja.
- 3) Terlambat masuk shift atau meninggalkan area kerja tanpa izin kepala unit (bukan asuhan darurat).

b. Ranah Disiplin Profesi (Klinis) :

- 1) Ketidaklengkapan pengisian berkas rekam medis dalam waktu kurang dari 24 jam pasca-pelayanan.
- 2) Tidak mengikuti orientasi atau pelatihan wajib internal yang telah dijadwalkan tanpa alasan sah.

2. Pelanggaran Sedang

Pelanggaran yang mencederai proses asuhan, menunjukkan perilaku tidak kooperatif (*disruptive behavior*), atau pengulangan dari pelanggaran ringan yang telah mendapat teguran tertulis.

a. Ranah Etik (Perilaku) :

- 1) Melakukan tindakan tidak sopan, berdebat kusir, atau membentak rekan kerja/pasien/keluarga pasien di depan umum.
- 2) Membuat konten media sosial di lingkungan rumah sakit yang menampilkan seragam/fasilitas rumah sakit tanpa izin, meskipun tidak menampilkan identitas pasien.
- 3) Mangkir dari tugas berturut-turut tanpa keterangan medis atau alasan kedaruratan yang sah.

b. Ranah Disiplin Profesi (Klinis) :

- 1) Melakukan tindakan klinis atau asuhan yang melandai/tidak sesuai SOP, tetapi belum sampai menimbulkan cedera fisik pada pasien.
- 2) Melakukan pendelegasian tugas klinis kepada sejawat yang belum memiliki kewenangan klinis (*clinical privileges*) tanpa supervisi.
- 3) Tidak melaporkan adanya Insiden Keselamatan Pasien (KNC/KTC) yang diketahuinya ke Komite Mutu/Keselamatan Pasien.

3. Pelanggaran Berat

Pelanggaran yang mengancam nyawa atau keselamatan pasien, melanggar hukum/pidana, merusak integritas profesi, atau merugikan rumah sakit secara

finansial dan hukum berskala besar.

a. Ranah Etik (Perilaku) :

- 1) Melakukan segala bentuk pelecehan (verbal, psikologis, emosional, atau seksual) terhadap pasien, keluarga pasien, sesama staf.
- 2) Membocorkan rahasia kedokteran/medis pasien ke media sosial atau pihak luar yang tidak berwenang.
- 3) Meminta atau menerima imbalan (gratifikasi/suap) dari pasien atau vendor farmasi/alkes untuk keuntungan pribadi yang memengaruhi keputusan klinis.
- 4) Bertugas atau berada di lingkungan rumah sakit di bawah pengaruh alkohol, narkotika, atau zat adiktif lainnya.

b. Ranah Disiplin Profesi (Klinis) :

- 1) Melakukan tindakan medis/keperawatan di luar batas kewenangan klinis (*clinical privileges*) yang dimiliki, kecuali dalam situasi bencana atau force majeure demi menyelamatkan nyawa.
- 2) Memalsukan dokumen klinis, menandatangani rekam medis atas nama orang lain, atau memanipulasi data asuhan pasien.
- 3) Mengabaikan panggilan kedaruratan pasien (code blue atau konsul cito) tanpa alasan yang dapat diterima secara medis, sehingga menyebabkan pasien mengalami Cedera Berat atau Kematian (Kejadian Sentinel)

5.2 Jenis Sanksi dan Rekomendasi Pembinaan

Penjatuhan sanksi di Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo menganut asas pembinaan berkelanjutan (*progressive discipline*), kecuali untuk pelanggaran berat yang dapat langsung dikenakan sanksi maksimal.

Tabel 5.2.1 Jenis sanksi dan Rekomendasi Pembinaan

Kategori Pelanggaran	Pilihan Sanksi Etik & Administratif (Oleh Direksi)	Pilihan Sanksi Disiplin Profesi (Rekomendasi Komite ke Direksi)
Ringan	Teguran lisan (dicatat di file SDM)	Teguran lisan oleh Kepala Unit
	Surat Peringatan Pertama (SP 1) dengan masa berlaku 6 bulan.	Kewajiban membuat refleksi kasus/membaca ulang SOP terkait.
Sedang	Surat Peringatan Kedua (SP 2) atau Ketiga (SP 3)	Pengurangan kewenangan klinis tertentu secara sementara
	Penundaan atau pemotongan insentif/jasa pelayanan selama periode tertentu	Praktik di bawah supervisi ketat (<i>supervision period</i>) selama 3-6 bulan
Berat	Skorsing kerja sementara (Metode dirumahkan)	Pencabutan Surat Penugasan Klinis (<i>Clinical Appointment</i>) secara sementara atau permanen.
	Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara tidak hormat.	Rekomendasi kepada Dinas Kesehatan dan Organisasi Profesi (IDI/PPNI/IBI) untuk pembekuan/pencabutan STR dan SIP.

5.3 Mekanisme Pertimbangan Sanksi

Sebelum merumuskan rekomendasi sanksi ke Direktur Utama, Sidang Pleno Komite Etik dan Disiplin wajib mempertimbangkan faktor-faktor berikut :

- Hal-Hal yang Meringankan :
 - Staf bersikap kooperatif, jujur, tidak berbelit-belit, dan mengakui kesalahan selama proses pemeriksaan/investigasi.
 - Staf belum pernah melakukan pelanggaran apa pun dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (rekam jejak bersih).
 - Pelanggaran terjadi karena adanya faktor sistemik rumah sakit (misalnya kelelahan ekstrem akibat shift ganda tak terencana, atau kerusakan alat medis yang tidak dilaporkan).
- Hal-Hal yang Memberatkan :
 - Staf mencoba menyembunyikan bukti, memanipulasi rekam medis, atau mengintimidasi saksi/pelapor selama investigasi.
 - Pelanggaran dilakukan secara sadar, sengaja, atau berulang (*recidivist*) untuk kasus yang sama.
 - Dampak pelanggaran menyebabkan kecacatan permanen atau kematian pada pasien, serta tuntutan hukum pidana/perdata bagi rumah sakit.

BAB VI

MONITORING DAN EVALUASI

6.1 Monitoring dan Pengawasan Aktivitas

Monitoring dilakukan secara berkesinambungan untuk memastikan bahwa penegakan etik dan disiplin profesi berjalan secara konsisten, objektif, dan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan.

1. Pengawasan Harian: Dilakukan oleh Kepala Ruangan atau Kepala Unit Kerja selaku lini pertama pengawas perilaku (*Code of Conduct*) staf di lapangan.
2. Rapat Koordinasi Rutin : Komite Etik dan Disiplin menyelenggarakan rapat koordinasi internal minimal 1 (satu) kali dalam sebulan untuk memonitor laporan/aduan yang masuk serta progres penanganannya.
3. Supervisi Lapangan : Komite melakukan telaah berkala terhadap implementasi budaya perilaku kerja yang aman di unit-unit berisiko tinggi (seperti IGD, ICU/NICU, dan Kamar Operasi).

6.2 Evaluasi Program Kerja

Evaluasi program dilakukan untuk menilai efektivitas regulasi, tren tingkat kepatuhan staf, serta performa komite dalam menyelesaikan konflik nilai atau pelanggaran disiplin. Evaluasi ini dibagi menjadi :

1. Evaluasi Semesteran (6 Bulan) : Menelaah tren jenis pelanggaran yang paling sering terjadi (misalnya perilaku kurang ramah atau kelalaian pengisian rekam medis) untuk dijadikan dasar penyusunan materi edukasi preventif pada semester berikutnya.
2. Evaluasi Tahunan (Rapat Kerja) : Menilai pencapaian target Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicators / KPI*) Komite Etik dan Disiplin.

6.3 Peninjauan Ulang Regulasi (Review)

Pedoman Etik dan Disiplin Rumah Sakit ini bersifat dinamis. Peninjauan ulang (*review*) terhadap isi pedoman dilakukan minimal 3 (tiga) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila terdapat :

1. Perubahan regulasi atau undang-undang kesehatan tingkat nasional yang bersifat mengikat.
2. Perubahan struktur organisasi atau arah kebijakan strategis rumah sakit.
3. Rekomendasi hasil evaluasi komite akibat adanya celah hukum (*loophole*) pada kasus-kasus pelik yang ditangani sebelumnya.

BAB VII

PELAPORAN

Hasil monitoring dan evaluasi wajib didokumentasikan dan dilaporkan secara berjenjang sebagai bentuk akuntabilitas tata kelola klinis dan manajemen :

1. Laporan Bulanan : Laporan intern komite mengenai rekapitulasi jumlah aduan, status penanganan kasus, dan kendala operasional sekretariat.
2. Laporan Berkala (Semester/Tahunan) : Komite Etik dan Disiplin menyusun laporan komprehensif yang berisi analisis data kasus, efektivitas sanksi, dan rekomendasi perbaikan sistemik rumah sakit untuk diserahkan secara resmi kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Pengawas Rumah Sakit.

BAB VIII

PENUTUP

Pedoman Pengorganisasian dan Pelayanan Komite Etik dan Disiplin Rumah Sakit ini disusun sebagai komitmen nyata Rumah Sakit Prima Husada Sukorejo dalam menegakkan moralitas, keselamatan pasien, dan profesionalisme kerja. Keberhasilan pelaksanaan pedoman ini tidak hanya bertumpu pada keaktifan anggota komite, melainkan pada kesadaran dan keteladanan dari seluruh jajaran manajemen, staf medis, keperawatan, hingga seluruh pegawai non-klinis.

Dengan diberlakukannya pedoman ini melalui Surat Keputusan Direktur Utama, maka seluruh civitas hospitalia wajib mematuhi setiap ketentuan, alur tata laksana, dan konsekuensi sanksi yang tertuang di dalamnya demi mewujudkan lingkungan pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan berintegritas tinggi.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 09 November 2025

Direktur Rumah Sakit Prima Husada



Ns.Heni Indra Wulansari, S.Kep,M.Kep